ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理 — 要約

解説「敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

拾ってから確定する

qSOFAで除外せずNEWS系で拾いSOFAで確定。抗菌薬は確信度×ショックの2軸で急ぐ

培養が先、入口は耐性リスク

血液培養を抗菌薬の前に2セット。初回量は腎機能で減らさない

感染源の制御は抗菌薬より効く

2〜6時間の窓と7日目の判定。培養が出たら狭めて部位ごとに短く止める

2 見つけて確定する — qSOFAで除外せず、培養を先に

詳しく

- **定義**：感染疑い＋SOFAの急性増加2点以上が敗血症。十分な輸液でもMAP 65以上に昇圧薬が要り乳酸>2 mmol/Lなら敗血症性ショック
- **qSOFAは感度23.1%**：単独のスクリーニングに使わない（SSC2026は強く反対）。院内の拾い上げはNEWS・NEWS2・MEWS・SIRS
- **PCTは始める判断に使わない**：感度0.62で4割近くを見逃す。出番は治療反応とやめるとき
- **血液培養は抗菌薬の前に**：末梢から2セット・各10 mL以上。先に採れば陽性率31.4%、抗菌薬の後は19.4%。例外は低血圧（ショック）だけ
- **乳酸は利用障害を映す**：高乳酸で$ScvO_2$ 70%未満は35%だけ。下げること自体を目標にせず傾きで追う

3 抗菌薬は確信度×ショックで急ぐ

詳しく

状態	入れる時刻	注意
ショックあり	確信度によらず直ちに。理想は認知から1時間以内	βラクタムをバンコマイシンより先に
ショックなし・probable以上	直ちに。理想は1時間以内	—
ショックなし・possible	時間を区切って評価し、懸念が続けば遅くとも3時間以内	3時間は感染かどうかを確かめる時間
unlikely	見送り、厳重に監視	—

- **possibleの3時間で探すもの**：敗血症疑いの最大3分の1は急性膵炎・組織虚血・血栓塞栓・血管炎・薬剤反応・HLHなどの「敗血症に見える病態」。始めた後も感染以外の原因が疑われれば止める
- **入口の広さは耐性リスクで**：市中発症の耐性菌はMRSA 10.8%・ESBL 7.3%・CRE 1.3%と稀なのにバンコマイシンは79.4%に入っていた。MDR・嫌気性菌・真菌はリスク因子があるときだけ足す
- **初回で入れ切る**：負荷量は分布容積で決まり腎機能で減らさない（減らすのは維持量だけ）。βラクタムは負荷のあと延長投与を既定に（SSC2026で強い推奨、短期死亡RR 0.91）

4 感染源の制御 — 2〜6時間で確実に、7日目は炎症で判定

詳しく

初日に感染源の制御の計画を立て、毎日「済んだか」を言う（未達成で死亡OR 2.60、達成でOR 0.63）

▼

腹膜炎

- 蘇生してから2〜6時間（死亡23.6%）
- 2時間未満の緊急介入は35.9%と多い。6時間を超えてよいわけではない

NSTI・カテーテル

- NSTIは理想6時間以内、遅くとも12時間以内。画像を待たず関係科を同時に呼ぶ
- カテーテルはショック・免疫抑制・持続菌血症で抜く

▼

7日目は「炎症が引いたか」で判定。炎症の遷延は死亡55.7%（OR 5.71）で、再手術の有無より重い

5 狭めてやめる — 部位ごとに短く、ダブルトリガーで止める

詳しく

- **デエスカレーションは強い推奨**：感受性が出たら狭める。病原体が同定されなくても提案される
- **期間は部位で**：市中肺炎5〜7日／複雑性尿路感染5〜7日／確実に制御した腹腔内感染4日／院内発症の血流感染7〜10日／S. aureus・カンジダ血流感染は最初の陰性血培から14日
- **中止はダブルトリガー**：臨床の改善（SOFA 2点以上低下）＋丸5日でPCT 80〜90%超かCRP 50%超の低下。届かなくても改善が続けば丸7日で中止
- **短期化しない**：黄色ブドウ球菌の菌血症・人工物・免疫不全・非発酵GNR・感染源の制御不十分。耐性菌だけを理由に延ばさない

- ☐ **培養陰性**を軽症や継続の口実にしない
- ☐ **抗菌薬の変更**で感染源の制御を代用しない
- ☐ **否定された補助療法**（PMX・ビタミンC・一般の敗血症へのIVIGなど）はやらない
- ☐ **申し送り**に確信度・培養・感染源・出口を書く

出典：本編の主要文献（SSC2026 CCM 2026；Sepsis-3 JAMA 2016；EUROBACT-2 ICM 2023／2025；AbSeS ICM 2022；ICM 2024 NSTI；IDSA 2026 耐性GNB；BLING III JAMA 2024；Crit Care 2025 ICUの抗菌薬最適使用 ほか）。SSC2026の時間とデエスカレーションの強い推奨は、エビデンスの確実性が「非常に低い」推奨です。